

FRACTURAS COSTALES FALTA POR HACER

DOLOR ABDOMINAL AGUDO*Dr. Pablo Díez González***CONCEPTO**

El dolor abdominal es un síntoma inespecífico de multitud de procesos, que puede originarse por causas intraabdominales o procesos extraabdominales, incluso por enfermedades sistémicas. Lo más importante será reconocer aquellos procesos intraabdominales graves, que requieran una solución quirúrgica urgente, que definimos como abdomen agudo.

Abdomen agudo: el conjunto de signos y síntomas de variada etiología cuyo nexo común es el dolor abdominal intenso que origina un compromiso sistémico al paciente, llegando a producir shock y fracaso multiorgánico en cuestión de horas si no se identifica y trata adecuadamente.

ETIOLOGIA

INFLAMATORIA-INFECCIOSA	ESTENÓTICA-OBSTRUCTIVA	GINECOLÓGICA	PERFORANTE	VASCULAR
Apendicitis aguda Colecistitis aguda Colangitis aguda Pancreatitis aguda Diverticulitis Megacolon tóxico (Enf. Inflamatoria intestinal)	Cáncer colorrectal Vólvulos de ciego y sigma Adherencias y bridas (cirugías previas) E.Crohn variante fibroestenótica-obstructiva Bezoares	Embarazo ectópico Rotura de fólculo ovárico o quiste lúteo Salpingitis	Úlcus gastroduodenal perforado Cuerpos extraños Estallido intestinal tras traumatismo u obstrucción evolucionada	Isquemia mesentérica aguda Aneurisma disecante de aorta Colitis isquémica Hemorragia intraperitoneal por rotura de víscera maciza por traumatismo o espontáneamente Hernias estranguladas (cuadro mixto por componente obstructivo)

DIAGNÓSTICO

El objetivo de la valoración del dolor abdominal agudo en urgencias es establecer un diagnóstico y confirmarlo con las pruebas complementarias correspondientes y determinar la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Aspectos fundamentales:

Clínica

Son muy útiles signos y síntomas tales como el inicio súbito de intensidad creciente, la irritación peritoneal o la alteración del tránsito intestinal.

Tipo De Dolor:

Somático o parietal: Dolor agudo, lancinante, bien localizado por el paciente y que aumenta de intensidad con la palpación. Se produce por inflamación del peritoneo parietal. Generalmente es la expresión de un proceso grave que requiere intervención quirúrgica urgente (perforación).

Esplácnico o visceral: Se produce por estimulación indirecta (distensión) o lesión de las terminaciones nerviosas situadas en la membrana serosa que envuelve los órganos internos. El organismo refiere el dolor a las metámeras superficiales circundantes, por esta razón se percibe difuso, impreciso (pancreatitis).

Referido: Es consecuencia de la irritación nerviosa adyacente a la lesión desencadenando dolor a distancia (dolor epigástrico en apendicitis), Puede tener origen torácico y referido por el enfermo en algún punto del abdomen. (neumonía, y cardiopatía isquémica).

Vómitos

Si se presentan tras el dolor orienta a un proceso agudo quirúrgico: colecistitis, apendicitis, oclusión intestinal, etc. Algunas veces modifican dicho dolor aliviando o empeorándolo.

Es útil conocer su frecuencia, volumen y coloración, en los casos de oclusión ya que nos permite diferenciar si ésta es alta (escasos, frecuentes y verdosos) o baja (abundantes, espaciados y fecaloideos).

Hipo

Se produce por hiperestimulación frénica en situaciones de irritación peritoneal secundaria a colecistitis, abscesos subfrénicos, etc.

Variación Del Tránsito Intestinal

Su ausencia más de 24 horas traduce una oclusión intestinal completa que indica intervención urgente. Es preciso distinguirla del íleo adinámico que puede aparecer concomitante con otras patologías.

La diarrea puede presentarse asociada a apendicitis, pero es un signo infrecuente de abdomen agudo quirúrgico.

Exploración física

- Inspección: Estado general del paciente, presencia de cicatrices, eventraciones, hernias, distensión abdominal, signos de deshidratación.
- Auscultación: Disminución o abolición del peristaltismo en la peritonitis; ruidos intestinales aumentados o con sonido metálico sugieren obstrucción.
- Palpación: Masas, megalias, hernias, defensa abdominal, dolor a la palpación, asimetría pulsos femorales, signos de irritación peritoneal. No olvidar la exploración de orificios herniarios)
- Percusión: Matidez o timpanismo. Ayuda en la valoración de irritación peritoneal, ascitis, visceromegalias, etc.
- Tacto rectal: Tono esfínter anal, presencia de heces en ampolla y sus características, existencia de masas o nódulos, valoración prostática (en hombres).

Pruebas complementarias

- Analítica de Sangre: Hemograma, coagulación, bioquímica (glucosa, urea, creatinina, iones, amilasa, pruebas de función hepática y/o PCR según la sospecha clínica).
- Analítica de orina: Sistemático, sedimento y test de embarazo.
- ECG: Descarta cardiopatía isquémica.
- Radiología: Esencial para la valoración de todo dolor abdominal.
 - Rx tórax posteroanterior.
 - Rx abdomen en decúbito supino.
 - Rx abdomen en bipedestación o decúbito lateral: en caso de duda diagnóstica.

NEUMOPERITONEO	SUGIERE PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA
Niveles centroabdominales	Sugiere obstrucción de i.delgado
Niveles en marco cólico	Sugiere obstrucción de i.grueso

- Ecografía abdominal: Valoración de cuadros de dolor abdominal de etiología incierta para apoyar diagnósticos de sospecha. Es la prueba gold standard en los casos de patología biliar.

- TAC abdominal: En situaciones de duda diagnóstica una vez realizadas previamente las pruebas necesarias antes descritas. (peritonitis global, oclusión mecánica intestinal, sospecha de disección aórtica e isquemia mesentérica aguda).

ACTITUD EN URGENCIAS

Valorar la estabilizada hemodinámica del paciente

- Aspecto general del paciente.
- Toma de constantes: TA, FC, FR y T^a.
- Determinar nivel de conciencia.
- Medidas generales
 - Dieta absoluta.
 - Sueroterapia según situación clínica y patología de base.
 - Sondaje nasogástrico en cuadros de oclusión intestinal.
 - Analgesia. Su utilización debe ser individualizada. Un dolor intenso tras ser analgesiado un paciente sugiere patología abdominal quirúrgica grave.
 - Antibioterapia: en los casos de abdomen agudo inflamatorio-infeccioso que cubra bacterias gramnegativas y anaerobias.
- Tratamiento específico del cuadro clínico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS CUADROS CLÍNICOS MÁS FRECUENTES

	Apendicitis	Colangitis y colecistitis litiasicas	Úlcus péptico perforado	Intestinal oclusivo	Intestinal isquémico
Localización	F.I.D.	H.D.	Epigastrio	Centro-abdominal	Perium-bilical
Irradiación	F.D. e hipogastrio	Escápula y hombro derecho	Fijo	Difusa	Difusa
Carácter	Continuo	Intenso y continuo	Sordo y urente	Cólico	Súbito y constric- tivo
Ritmo	Inicio progresivo	Inicio brusco	Brusco, postprandial	Crisis a intervalos	Post- prandial
Signos y síntomas asociados	Fiebre, náuseas y vómitos.	Fiebre, vómitos +/- ictericia	Náuseas, distensión abdominal	Peristal- tismo de lucha	Sudo- ración. Diarrea sangui- nolenta
Analítica	Leucocitosis	Leucocitosis, +/- aumento de GGT y ALP.	Normal /leucocitosis	Normal	Leucoci- tosis intensa
Diagnóstico	Clínico y analítico	Clínico y ecográfico.	Clínico. Rx y/o T.C.	Rx y/o T.C.	Angio-T.C.
Tratamiento	Quirúrgico	Médico / quirúrgico	Quirúrgico	Médico / quirúrgi-co	Quirúr-gico

Lectura: F.I.D.: Fosa Iliaca derecha. F.D.: Flanco derecho. H.D.:Hipocondrio derecho T.C.: Tomografía computada.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez A, Blázquez JA, Fuertes A, García JD, PérezJL. Propedéutica clínica. 3º ed. Universidad de Salamanca; 2006.
- Silen W. Cope's early diagnosis of the acute abdomen. 21º ed. New York: Oxford University Press; 2005.

- Flasar MH, Goldberg E. Acute abdominal pain. Med Clin North AM. 2006;90:481-503.
- Cartwright SL, Knudson MP. Evaluation of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician, 2008;77:971-8.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez, FJ. Medicina de urgencias y emergencias.

APENDICITIS AGUDA. PLASTRÓN APENDICULAR

Lourdes Galán Raposo

INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda se define como la inflamación aguda del apéndice cecal, provocada habitualmente por la obstrucción de su luz y sobreinfección bacteriana posterior. Sin un tratamiento oportuno puede evolucionar hacia la perforación apendicular, generando una peritonitis o un plastrón apendicular (masa formada por los tejidos adyacentes al apéndice perforado delimitando el proceso infeccioso).

Es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente, con un pico de incidencia en la 2ª y 3ª década de la vida, sin diferencias entre ambos sexos.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal. En la presentación típica, el dolor se localiza inicialmente a nivel periumbilical migrando a fosa ilíaca derecha a medida que la inflamación progresa. Esto ocurre en el 50-60% de los casos. Además del dolor abdominal puede existir anorexia. En un 60-70% de los casos existen náuseas y vómitos en las primeras horas, aunque suelen ser posteriores al inicio del dolor. Si lo preceden, hay que dudar del diagnóstico de apendicitis aguda. Otros síntomas menos frecuentes son la diarrea (por irritación rectosigmoidea) y el síndrome miccional (por irritación de la vejiga urinaria). La temperatura suele alterarse a las 4-8 horas de iniciarse el cuadro, elevándose ligeramente, entre 37,5-38 °C. Se debe desconfiar del diagnóstico cuando la fiebre preceda al dolor o cuando sea superior a 39 °C sin contar con otros datos clínicos, sobre todo de palpación abdominal, sugestivos de una complicación evolutiva. En muchos pacientes los síntomas iniciales son inespecíficos (flatulencias, dispepsia, diarrea, hábito intestinal irregular, malestar generalizado).

Exploración física

Inspección

El estado general del paciente depende del tiempo de evolución del proceso. En las primeras horas suele ser bueno, evitando los movimientos innecesarios y en posición antiálgica (decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas). En las fases avanzadas el estado general suele deteriorarse.

Palpación

Destaca la presencia de dolor en fosa ilíaca derecha, sobre todo en el **Punto de McBurney** (situado en la unión de 1/3 externo con los 2/3 internos de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha). La presión sobre el resto del abdomen resulta molesta, irradiándose hacia el cuadrante inferior.

Signos que podemos encontrar en relación con la irritación peritoneal

- Dolor en fosa ilíaca derecha con los movimientos, la tos o la percusión.
- Defensa muscular involuntaria a la palpación (comparar con la palpación del lado contralateral).
- Dolor producido por la descompresión brusca tras la presión (signo de Blumberg)
- Dolor en fosa ilíaca derecha desencadenado por la descompresión brusca en FII (signo de

Rovsing).

- Dolor en fosa ilíaca derecha con la hiperextensión pasiva o la flexión activa de la cadera ipsilateral (signo del psoas). Orienta hacia una localización apendicular retrocecal.
- Dolor en fosa ilíaca derecha con la rotación interna de la cadera con la rodilla flexionada (signo del obturador). Sugestivo de apendicitis pélvica.

Estos signos no son diagnósticos por sí solos.

En el caso de absceso o plastrón apendicular, puede palparse una masa con signos inflamatorios en fosa ilíaca derecha. Si existe una peritonitis aguda difusa, el dolor es intenso, generalizado y se acompaña de irritación peritoneal difusa (contractura de toda la musculatura abdominal).

Exploración ginecológica

Se debe realizar en las mujeres para descartar patología anexial.

Pruebas complementarias

PRUEBAS DE LABORATORIO

En aproximadamente el 80% de los pacientes existe una elevación moderada en la cifra de leucocitos (leucocitosis con neutrofilia) y de los reactantes de fase aguda.

No se debe olvidar el realizar un test de embarazo en mujeres en edad fértil para el diagnóstico diferencial con patología ginecológica.

Las pruebas de laboratorio no sirven por sí solas para establecer el diagnóstico. En ocasiones pueden orientar a otras patologías.

PRUEBAS DE IMAGEN

Radiología

La radiología de tórax descarta la existencia de afecciones cardiopulmonares. La radiología simple de abdomen puede ser normal.

Ecografía

Prueba de imagen de elección. Una ecografía normal no excluye el diagnóstico de apendicitis aguda.

TAC Abdominal

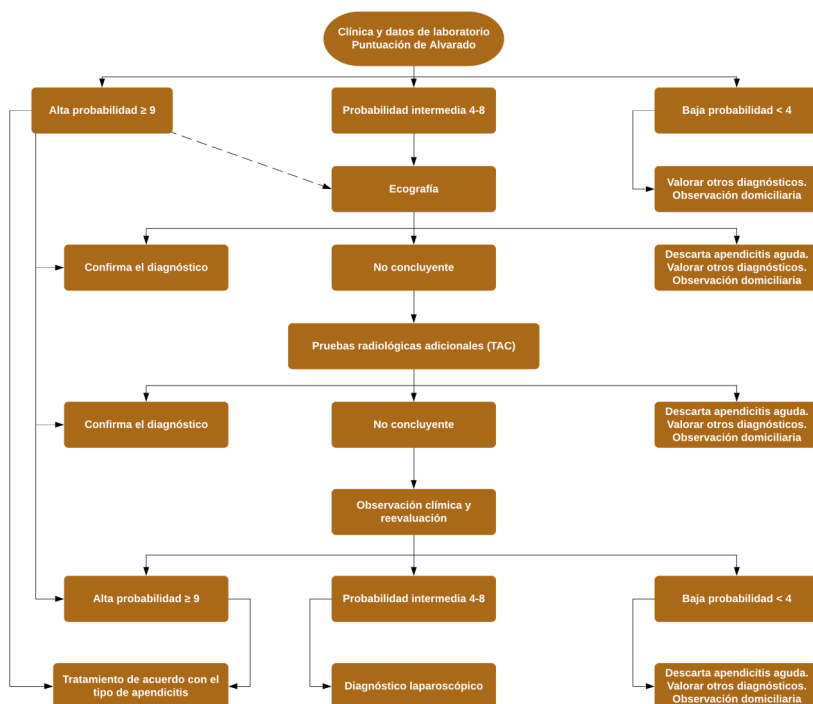
Indicada en pacientes obesos y en ancianos por sospecha de patología tumoral o diverticular.

El diagnóstico de la apendicitis aguda es esencialmente clínico. Se han descrito escalas prácticas para el diagnóstico temprano, como la de Alvarado y se han propuesto algoritmos diagnóstico-terapéuticos.

Variables		Puntuación
Síntomas	Migración del dolor a cuadrante inferior derecho	1
	Anorexia y/o cetonuria	1
	Náuseas y/o vómitos	1
Signos	Dolor en cuadrante inferior derecho	2
	Rebote	1
	Elevación de la temperatura > 38°C	1

Variables		Puntuación
Laboratorio	Leucocitosis > 10.500 por mm3	2
	Desviación a la izquierda de neutrófilos > 75%	1
Total		10

Escala de Alvarado. Puntuación para el diagnóstico de apendicitis aguda
 Algoritmo diagnóstico-terapéutico propuesto por European Association for
 Endoscopic Surgery (EAES. Reunión de Consenso de Bucarest 2015)



Diagnóstico diferencial

Es fundamental distinguir procesos que requieran tratamiento quirúrgico

- **En niños:** linfadenitis mesentérica, gastroenteritis aguda, invaginación intestinal*, neumonía basal derecha.
- **En adolescentes y adultos jóvenes:** linfadenitis mesentérica, ileitis terminal, Crohn, cólico ureteral derecho.
- **En mujeres:** enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico*, ovulación dolorosa, rotura folicular.
- **En adultos y ancianos:** colecistitis aguda, úlcus péptico perforado*, diverticulitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica*, pancreatitis aguda, cáncer de ciego*, torsión de quistes o tumores ováricos*, infarto agudo de miocardio, neumonía basal, pericarditis.

* Requieren tratamiento quirúrgico.

Situaciones especiales

Apendicitis Aguda En El Niño

Es un proceso más grave que en adulto por la alta probabilidad de perforación y el diagnóstico tardío ya que el cuadro clínico es menos típico (fiebre más alta, más vómitos y diarrea). Difícil de distinguir de la gastroenteritis aguda.

Apendicitis Aguda En El Embarazo

Es el trastorno extrauterino más frecuente que requiere tratamiento quirúrgico durante el embarazo. Más frecuente en el primer y segundo trimestre, siendo la clínica similar a las pacientes no embarazadas. En el tercer trimestre el dolor se localiza en flanco derecho-hipocondrio derecho por el ascenso del ciego.

Apendicitis Aguda En El Anciano

Es un proceso grave debido a la alta frecuencia de perforación. Suele existir retraso en el diagnóstico por presentar un cuadro clínico atípico: poco frecuentes la fiebre y los vómitos.

Apendicitis Aguda En El Inmunodeprimido

Tiene la misma incidencia que en la población general. Puede presentarse con la clínica típica, aunque es rara la presencia de leucocitosis. Se debe realizar diagnóstico diferencial con la enterocolitis neutropénica y la tiflitis por CMV.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Dieta absoluta.
 - Sueroterapia. Analgesia.
 - Valoración por el Servicio de Cirugía para tratamiento quirúrgico.
- La anamnesis y la exploración física completa son puntos fundamentales en la valoración del paciente con sospecha de apendicitis aguda.
 - Se debe realizar un test de embarazo a todas las mujeres en edad fértil
 - “Si náuseas, vómitos y fiebre preceden al dolor, estoy convencido de que no se trata de una apendicitis aguda”(Murphy)

BIBLIOGRAFÍA

- Gorter RR, et al. Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2015. Surg Endosc (2016) 30: 4668-4690
- CM Townsend, RD Beauchamp, BM Evers, KL Mattox. Sabiston Tratado de Cirugía. 19ª edición. Editorial Elsevier España. Barcelona 2013
- Parrilla Paricio P., Landa García J.I. Cirugía AEC. 2ª edición. Editorial Panamericana. Madrid 2010.

NEUMOPERITONEO. PERFORACIÓN VÍSCERA HUECA.

Blanca Amada de Urrutia y Nadal

INTRODUCCIÓN

El interés que supone el neumoperitoneo como signo clínico se basa en la frecuencia con la que nos encontramos en la práctica clínica diaria su causa principal, la perforación de víscera hueca (supone el 90% de los neumoperitoneos y la gran mayoría -hasta el 90%- requerirá un abordaje quirúrgico). La perforación de víscera hueca es responsable de hasta un 5-10% de las causas de abdomen agudo, con el impacto que esto tiene en la asistencia hospitalaria urgente y en tasas de morbi-mortalidad secundaria.

Una adecuada aproximación en el Servicio de Urgencias, mostrando un alto índice de sospecha y basado en conocimientos anatómicos, fisiológicos y microbiológicos permitirán el diagnóstico y tratamiento precoz, con disminución de complicaciones derivadas.

INFLAMATORIO	INFLAMATORIO	INFLAMATORIO
Perforación visceral o por cuerpo extraño	Obstrucción intestinal	Hemorragia intraperitoneal
Peritonitis primaria	Obstrucción biliar	Isquemia (trombosis/embolismo mesentérico)
Gastroenterocolitis	Torsión epiploica	Infarto esplénico
Enfermedad inflamatoria intestinal	Ginecológico	
Ginecológico		
Diverticulitis de Meckel		
Pancreatitis		
Absceso hepático / esplénico		
Linfadenitis mesentérica		
Uro-Ginecológico		

Diagnóstico diferencial abdomen agudo

DIAGNOSTICO

Antes de entrar en profundidad en la aproximación diagnóstica, resulta interesante clasificar los tipos de dolor que nos orientarán en la práctica diaria.

- Dolor visceral: Secundario a contracción o espasmo visceral con estimulación de estructuras nerviosas aferentes. Este dolor se referirá en la línea media, a distinta altura (epigastrio, mesogastrio o hipogastrio) según el origen embrionario de las vísceras intraabdominales afectadas.
- Dolor parietal: Secundaria a irritación peritoneal directa.
- Dolor referido: Percibido en una zona alejada del lugar donde se localiza el proceso patológico.

Intestino Proximal	3ª porción duodenal a 2/3 colon transversal	Epigastrio
Intestino Medio	3ª porción duodenal a 2/3 colon transversal	Mesogastrio
Intestino distal	Último tercio colon transversal a recto	Hipogastrio

A continuación, desarrollamos de forma esquemática la aproximación diagnóstica del proceso que nos ocupa.

Antecedentes médico-quirúrgicos generales.

Mostrando interés en los antecedentes de cirugía previa abdominal, tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, corticoides o quimioterapia, así como antecedentes de úlcera gastroduodenal previa o enfermedad diverticular.

DOLOR	SÍNTOMA GUÍA
LOCALIZACIÓN	Localizado / Difuso
INICIO	Súbito / Progresivo
DURACIÓN	Horas / Días; Continuo / Discontinuo
CARACTERÍSTICAS	Urente / Agudo / Desgarrante / Opresor / Sordo
FACTORES MODIFICADORES	de alivio o exacerbadores

Anamnesis.

El síntoma que referirá el paciente y por el que nosotros debemos atender como guía es el **dolor**.

DOLOR	SÍNTOMA GUÍA
LOCALIZACIÓN	Localizado / Difuso
INICIO	Súbito / Progresivo
DURACIÓN	Horas / Días; Continuo / Discontinuo
CARACTERÍSTICAS	Urente / Agudo / Desgarrante / Opresor / Sordo
FACTORES MODIFICADORES	de alivio o exacerbadores

Interrogaremos sobre su localización (si es difuso o localizado y de ser localizado, el cuadrante/s dónde lo ubica - se le puede pedir que lo señale con el dedo-), inicio (súbito o progresivo/gradual), duración (tiempo de evolución -horas, días...- y si es continuo/discontinuo), características (sordo, urente, desgarrante, opresor...) y por último factores modificadores, tanto de mejoría como exacerbadores (movimiento, ingesta alimentaria...).

Preguntaremos también sobre otros síntomas asociados: Fiebre o sensación distémica; Náuseas o vómitos; Síncope asociado al inicio del dolor.

Exploración física.

La realizaremos de forma sistemática y a poder ser, siempre en el mismo orden de cara a evitar que se nos olviden algunos aspectos de la misma.

Valoración del estado general: Con la simple inspección valoraremos si nos impresiona de gravedad por un mal o regular **estado general** o por el contrario el aspecto de inicio es bueno.

Aquí podremos detenernos y valorar si adquiere **posturas antiálgicas**, la **coloración** e **hidratación cutáneo-mucosa**, que nos podrá orientar a situaciones de deshidratación aguda o mala perfusión periférica y valorar el **Glasgow**, alterado en procesos que cursen con shock.

Constantes vitales: Nos interesa identificar de forma precoz aquellos pacientes que puedan encontrarse en situación de inestabilidad hemodinámica establecida o con riesgo de establecerse en un breve periodo de tiempo, ya que esto podrá determinar que no sea posible realizar determinadas pruebas complementarias o requieran la valoración por la Unidad de Cuidados Intensivos.

Determinaremos: **Temperatura** (Atención a la hipotermia, puede ser síntoma de shock), **tensión arterial**, **frecuencia cardíaca**, **frecuencia respiratoria** y **saturación periférica de oxígeno**.

Exploración abdominal: Prestaremos atención a los siguientes puntos.

- Observación / Inspección: Aspecto general del mismo (hundido, distendido a tensión o no) y movimiento en relación con la respiración (movimiento paradójico, limitado...)
- Auscultación. Identificación de ruidos peristálticos y sus características: Si están **ausentes** puede ser secundario a una peritonitis establecida o íleo; si están aumentados, puede ser secundario a un patrón obstructivo.
- Palpación y Percusión*: Valoraremos la presencia de **defensa abdominal localizada o generalizada** (signo de irritación peritoneal subyacente) iniciando la exploración lejos del punto de máximo dolor señalado por el paciente*.
- Es importante determinar si la presencia de defensa abdominal es de origen involuntario (irritación peritoneal) o de origen voluntario (ansiedad). Una manera para determinarlo es pidiendo al paciente que flexione las piernas; en caso de defensa abdominal involuntaria, seguirá manifestándose en esta posición.

Igualmente es importante explorar las regiones inguino-crurales y umbilical a descartar la presencia de hernias.

Pruebas complementarias.

Pruebas De Laboratorio

Solicitaremos una analítica general con **hematocrito, fórmula leucocitaria, recuento de plaquetas, coagulación, bioquímica** (solicitando específicamente función renal y electrolitos, pruebas de función hepática, lipasa y amilasa, y reactantes de fase aguda -PCR, procalcitonina, fibrinógeno-) y sedimento urinario con amilasa. Se puede completar con la extracción de una **gasometría arterial** que nos determine pH y exceso de bases.

Pruebas Radiológicas

- Radiografía de Tórax. La radiografía de tórax en bipedestación y en una proyección postero-anterior, es la **prueba de elección** para determinar la existencia de neumoperitoneo.
- Radiografía de Abdomen. Segunda prueba de elección si el tórax no es factible, habrá que realizarla en decúbito lateral izquierdo y con rayo horizontal.
- TC Abdomino-Pélvico. Con una alta sensibilidad (entre el 85-100%) nos podrá identificar neumoperitoneo y otros signos directos o indirectos de perforación de víscera hueca. El paciente deberá encontrarse **estable hemodinámicamente** para poder realizarse la prueba en condiciones de seguridad.

Aire subdiafragmático derecho	Signo radiológico más frecuente
Signo de Rigler o de la doble pared intestinal	Visualización de la pared intestinal por contraste con el aire extraluminal en disposición interesas.

Aire subdiafragmático derecho	Signo radiológico más frecuente
	

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Interesa llegar a un diagnóstico diferencial precoz con intención de no demorar el inicio de tratamiento. Esquemáticamente la aproximación terapéutica en Urgencias consistirá en los siguientes apartados.

- Dieta. Mantendremos al paciente en **dieta absoluta**.
- Monitorización. Tendremos, en la medida de lo posible, al paciente monitorizado, atendiendo a posibles alteraciones de constantes que requieran reajuste de tratamiento o revalorización de la situación clínica.
- Acceso venoso periférico.
- Fluidoterapia. Iniciaremos la infusión de cristaloides de forma precoz, basándonos en la estimación de pérdidas y teniendo en cuenta posibles comorbilidades concomitantes (insuficiencia cardíaca, por ejemplo)
- Sondaje vesical. Interesa el control de la diuresis, como orientación sobre el estado de perfusión tisular y detección precoz de estados de sepsis/shock, así como para el reajuste del aporte de líquidos.
- Tratamiento específico. Solicitaremos valoración al cirujano general de guardia que decidirá la actitud terapéutica a seguir (quirúrgica o no)
- Antibioterapia. Iniciaremos una terapia preoperatoria **antibiótica de amplio espectro** de acuerdo a los protocolos de cada centro que tengan en cuenta resistencias específicas, las posibles alergias o intolerancias del paciente, así como comorbilidades preexistentes. Posteriormente según resultados de la exploración quirúrgica o resultado de cultivos microbiológicos, dirigiremos la pauta antibiótica.

BIBLIOGRAFÍA

- John T. Langell, MD, PhD, MPH; Sean J. Mulvihill, MD. Gastrointestinal perforation and the acute abdomen. Med Clin N A, 92 (2008) 599-625.
- F. Moreno Antón, J. García-Donas. Neumoperitoneo no quirúrgico. Rev Clin Eso

2004;204:372-4 - Vol, 204 Num 7

- F. Basterrechea Iriarte. Neumoperitoneo hallazgos en radiología simple. SERAM 2012. Póster nº S-0788

PATOLOGÍA MAMARIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Maria Berdeal Diaz

INTRODUCCIÓN

En este capítulo tratamos de exponer los motivos de consulta más habituales, con el objetivo de conocer el manejo inicial, su diagnóstico diferencial y establecer criterios de derivación a consultas especializadas.

Las causas de consulta son:

- Dolor mamario.
- Nódulo palpable.
- Secreción mamaria.
- Lesiones cutáneas.
- Traumatismos mamarios.
- Otras (seroma, hematomas, extrusión de prótesis...)

Dolor mamario

Causa más frecuente de consulta.

- Dolor mamario cíclico o mastodinia (67%): mujeres de edad fértil, suele aparecer en alguna fase del ciclo menstrual, bilateral.
- Dolor mamario no cíclico o mastalgia (23%): continuo y habitualmente unilateral. Puede deberse a un proceso inflamatorio, fibroadenomas, quistes de crecimiento rápido...

Diagnóstico diferencial

DOLOR MAMARIO	MUSCULO-ESQUELÉTICO	DOLOR REFERIDO	OTROS
MASTODINIA MASTITIS TRAUMATISMO MAMARIOS ENF. MONDOR QUISTES GINECOMASTIA CONTRACTURA CAPSULAR (portadoras de prótesis mamarias) POSTQUIRÚRGICO (neuromas, mama fantasma...) TUMORES BENIGNOS CÁNCER	DOLOR DE PARED COSTAL COSTOCONDRIITIS FRACTURAS COSTALES SD. TIETZE (inflamación entre el 2º y 3º cartílago intercostal) FIBROMIALGIA RADICULOPATIA CERVICAL	ENFERMEDAD CORONARIA PERICARDITIS TROMBOEMBOLISMO PULMONAR PLEURITIS REFLUJO GASTROESOFÁGICO ÚLCERA GASTRODUODENAL	PSICOLÓGICO HERPES ZOSTER FARMACOS: - Tratamientos hormonales. - Antidepresivos, antipsicóticos. - Antihipertensivos, tratamientos cardiológicos (digoxina). - Antibióticos, antifúngicos. - Otros (ciclosporina, domperidona, metadona).

Anamnesis

Características del dolor, localización (uni/bilateral), duración, irradiación, intensidad, forma de aparición, tiempo de evolución, factores que lo exacerben o lo desencadenen, relación con los ciclos menstruales, cirugías previas, traumatismos previos, ingesta de fármacos.

Exploración física

Valorar si existen signos inflamatorios, deformidades, cicatrices, lesiones cutáneas, nódulos palpables, adenopatías axilares, escoliosis o cifosis, lesiones en la pared costal o dolor a la palpación.

Pruebas complementarias

- Ecografía mamaria: mastitis ,absceso mamario, hematoma...
- Rx tórax y parrilla costal: sospecha de fracturas costales, costo-condritis.
- Rx columna cervical y dorsal: radiculopatías.

Tratamiento

Iniciar tratamiento específico en aquellos casos de dolor extramamario.

Tratamiento sintomático para el dolor

La mayoría de casos se **derivarán a una consulta especializada** de patología mamaria, para completar estudios.

MASTITIS

Clasificación

MASTITIS INFECCIOSAS	A- Simple: 1.Purulenta. 2.No purulenta B- Complicada: 1. Absceso. 2.Fistulizante. 3. Quiste infectado 4.Galactocele infectado. 5. Seroma o colección postquirúrgica infectada C-Mastitis específicas: 1.Mastitis tuberculosa 2.Mastitis fungica
MASTITIS NO INFECCIOSAS	A-Mastitis primarias de la mama: 1.Mastitis periductal o Ectasia ductal 2.Mastitis granulomatosa idiopática 3. Pseudotumor inflamatorio B-Mastitis secundarias: 1.Postradioterapia: Mastitis r�dica 2.Postrum�tica: Necrosis grasa 3.Secundaria a cuerpo extra�o: Siliconomas 4.Secundarias a patolog�a sist�mica: -Mastopat�a diab�tica -Mastitis l�pica -Amiloidosis -Sarcoidosis -Vasculitis
PATOLOG�A MALIGNA	A- Carcinoma inflamatorio B- Tumores de mama abscesificados

MASTITIS INFECCIOSA SIMPLE

El *S. aureus* es el agente causal m s frecuente de las mastitis infecciosas (75%). Otros agentes pueden ser *Streptococo*, enterobacterias,levaduras.

Cl nica: Dolor intenso de la mama con signos inflamatorios (enrojecimiento, tumefacci n e induraci n). Puede acompa arse de fiebre, mialgias, escalofr os y malestar general (m s frecuente en las mastitis puerperales) y adenopat as axilares.

Diagnóstico Clínico

Es necesario realizar una **ECOGRAFÍA** para descartar absceso subyacente y un **ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO** de la leche(puerperales) y de la secreción mamaria(no puerperales).

- **Puerperal:** Es la forma más común de mastitis infecciosas. Ocurren durante la lactancia. Pueden ser uni o bilaterales. Los principales factores predisponentes son la ingurgitación y obstrucción de un conducto lácteo, la presencia de grietas en el pezón o una mala técnica de lactancia.
 - **Tratamiento:** Vaciamiento eficaz de la leche. Aplicar compresas tibias.
 - **Analgésicos, antiinflamatorios y antibiótico:** Ciprofloxacino 750mg/12 h durante 14 días o Trimetopin-Sulfametoxazol 160/800/12h durante 14 días. En pacientes alérgicas se puede emplear Cloxacilina o Eritromicina. Puede **mantenerse la lactancia**.
- **No puerperal:** Son menos frecuentes. Los factores predisponentes son infecciones de las glándulas de Montgomery, heridas, eccema...
 - **Tratamiento:** analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos: Amoxicilina/Clavulámico o eritromicina+metronidazol en pacientes alérgicas.
 - **Remitir a consulta especializada** para valoración. En caso de mala respuesta tras 1 semana de tratamiento se realizarán estudios diagnósticos para poder establecer el diagnóstico diferencial con un carcinoma inflamatorio u otras causas de mastitis no infecciosa.

MASTITIS INFECCIOSA COMPLICADA

- **Absceso mamario:** Se considera una urgencia quirúrgica, es preciso evacuarlo y tomar una muestra para cultivo. **Avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA.**

Nódulo palpable

Motivo de consulta muy frecuente. Se necesitará estudios complementarios específicos para el diagnóstico. **Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente** si nódulo de reciente aparición, crecimiento rápido, de consistencia dura, irregular, fijo a planos profundos o que provoque retracción cutánea

Secreción mamaria

En el 95% de los casos es secundaria a procesos benignos. Por sus características diferenciamos:

- Galactorrea: secreción láctea no fisiológica, es bilateral y secundaria a procesos funcionales (hiperprolactinemia, fármacos, estrés...)
- Telorrea: líquido más o menos denso, que puede ser claro u oscuro, uni o bilateral y por uno o múltiples orificios. Puede tratarse de procesos funcionales o procesos orgánicos (papilomas y los adenomas del pezón)
- Telorragia: la secreción sanguinolenta uniorificial y unilateral debe hacernos sospechar en un proceso tumoral.

Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente si existe telorragia, secreción uniorificial, unilateral y espontánea o si asocia un nódulo palpable.

Lesiones cutáneas

DERMATOSIS ESPECÍFICAS DE LA MAMA (Poco Frecuentes)

- Enfermedad de Paget del pezón: lesión eccematosa o erosiva que afecta a la piel de la areola y/o el pezón. No responde a tratamiento con corticoides. El diagnóstico es anatomo-

patológico. Se asocia a un carcinoma subyacente en 87% de casos.

- **Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente.**
- Adenomatosis erosiva del pezón: es una lesión benigna que simula la Enfermedad de Paget.

DERMATOSIS NO ESPECÍFICAS (Frecuentes)

- Eccema: lesión muy prevalente que se caracteriza por eritema, descamación y prurito asociado. Afecta generalmente al complejo areola pezón. Tratamiento: corticoides tópicos.
- Intertrigo submamario: lesiones eritematosas en surco submamario.
 - Intertrigo candidiásico: pústulas satélite. Tratamiento: imidazólicos.
 - Intertrigo psoriásico. Tratamiento: corticoides tópicos.
 - Intertrigo irritativo. Tratamiento: corticoides tópicos.
- Hidradenitis supurativa. Tratamiento: drenaje quirúrgico en lesiones muy inflamadas y dolorosas. Tetraciclinas reducir la inflamación asociada.
- Herpes zoster o herpes simple. Tratamiento: Valaciclovir 1gr/8h 7 días (Herpes zoster) y 500 mg/12h 5 días (Herpes simple)
- El herpes zoster si no se trata en las primeras 72 horas presenta mayor riesgo de neuralgia postherpética.
- Escabiosis: afecta típicamente a la zona periareolar en las mujeres. Buscar lesiones similares pruriginosas a nivel genital, en manos y pies.

Traumatismos mamarios:

- Traumatismos penetrantes: pueden asociar lesiones torácicas (fracturas costales, hemo neumotórax, taponamiento pericárdico)
- Traumatismos cerrados: 98% por accidentes de tráfico-colisión. Puede asociar lesiones intrabdominales (desgarros mesentéricos), fracturas de clavícula, esternón, costillas, vértebras, extremidades...

		SINTOMAS / SIGNOS	TRATAMIENTO
I	LESIÓN LEVE APLASTAMIENTO	EQUIMOSIS/ AMPOLLA	Analgesia+ Observación
II	LESIÓN MODERADA APLASTAMIENTO	HEMATOMA/NECROSIS GRASA AFECTACIÓN CUTÁNEA LACERACIONES	Sutura Drenaje hematoma Ecografía mamaria
III	LESIÓN SEVERA APLASTAMIENTO	TRANSECCIÓN PARCIAL/COMPLETA HENDIDURA MAMARIA DIAGONAL	Tratamiento quirúrgico
IV	LESIÓN AVULSIÓN	AVULSIÓN PARCIAL/COMPLETA SANGRADO ACTIVO	TAC Torácico Angiografía + embolización Cirugía.

Clasificación de traumatismos mamarios (MAJESKI). **Avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA** en traumatismos severos (III-IV)

Otras

- Complicaciones postquirúrgicas: Seroma, sangrado, hematoma, dehiscencia de suturas, extrusión de prótesis. En estos casos es necesario **avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA** para valoración.

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Práctica Clínica en Senología. Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria.
- ISBN:978-84-608-1664-5.
- Manual de la Asociación Española de Cirujanos.ISBN978-84-9835-282-5.
- Majeski J.Shoulder restraint injury of the female breast.Int. Sur.2007Mar-Apr;92(2):99-102.

PATOLOGIA ANORRECTAL AGUDA

I. Oliva López, LM. Alcoba García

HEMORROIDES

Introducción

Son cojinetes mucosos formados por contenido venoso y músculo liso. En ausencia de clínica no precisan tratamiento; pasan a ser hemorroides cuando se dilatan los plexos venosos, tendiendo entonces a ingurgitarse, sangrar y prolapsarse.

Se localizan muy cerca del orificio anal. Constan de 3 nódulos situados a las 3, 7 y 11 horas de la esfera de un reloj.

- Hemorroides externas: dilatación de venas hemorroidales o rectales inferiores. Se localizan en el tercio distal del canal anal.
- Hemorroides internas: dilatación del plexo hemorroidal interno formado por venas rectales superior y media. Este plexo se encuentra en el espacio submucoso, por encima de las válvulas de Morgagni.

Clasificación

- Grado I: no sobresalen del canal anal y sangran sin dolor.
- Grado II: se prolapsan durante la defecación y se reducen espontáneamente.
- Grado III: se prolapsan durante la defecación y no se reducen espontáneamente. Precisan reducción manual.
- Grado IV: prolapso permanente y son irreductibles.

Clínica

- **Rectorragia:** sangre roja, no mezclada con las heces. Lo más frecuente es que sea leve aunque en ocasiones puede causar anemia y shock.
Prolapso hemorroidal: exteriorización de hemorroides internas. Se asocia a prurito, manchado (soiling), e incluso necrosis.
Crisis hemorroidal aguda: dolor y edematización de la zona, discomfort, sensación de ocupación.
- **Trombosis hemorroidal:** dolor, induración perianal y coloración violácea. Puede asociarse a fiebre.

Tratamiento

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.
- AINES (Ibuprofeno, Enantyum, etc.) de forma pautada.
- Laxantes formadores de bolo fecal (Plantaben).
- Medicamentos flebotónicos: han demostrado eficacia a dosis elevadas frente a las hemorragias.
- Pomadas anestésicas de contacto o con hidrocortisona: de dudoso uso en las crisis hemorroidales.
- Trombectomía bajo anestesia local: En caso de trombosis hemorroidal.
- Si se objetiva necrosis asociada a la trombosis hemorroidal se debe realizar una hemorroidectomía urgente.

Debe valorarse de forma programada en Consulta de Cirugía General una vez pasada la fase aguda. Es importante descartar otras patologías como el cáncer colorrectal, para lo cual será precisa la realización de una colonoscopia.

- Debe realizarse una colonoscopia programada para descartar neoplasia colorrectal.

FISURA ANAL

Introducción

Ulceración lineal dolorosa punzante que se extiende desde la línea pectínea hasta el margen anal, generalmente en la línea media posterior, asociada a hipertonía del esfínter.

Diagnostico

- Clínica:
 - Dolor anal intenso lacerante asociado a la defecación. Se presenta a su vez con sangre fresca tras la deposición.
 - Estreñimiento, como consecuencia del dolor de la deposición.
 - “Hemorroide centinela”: no es una hemorroide propiamente dicha, sino de una inflamación del extremo inferior de la herida.
 - Hipertonía del esfínter interno (EI): El dolor causa espasmo reflejo del EI que condiciona mayor dolor y mala irrigación de los bordes de la fisura, lo cual impide su correcta cicatrización y se inicia un círculo vicioso de: herida-dolor-hipertonía-isquemia-herida.
- Exploración física: Se objetiva úlcera en margen anal (normalmente en cara posterior) e hipertonía del esfínter.

- No se debe realizar tacto rectal por la intensa hipertonía del esfínter anal.

Tratamiento

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.
- Laxantes formadores de bolo (Plantaben) o aceites de parafina: Pueden asociarse en presencia de estreñimiento.
 - Analgésicos de forma pautada en las crisis dolorosas. Puede asociarse un relajante muscular (Diacepam), o incluso infiltración con anestésico local.
 - Uso de crema cicatrizante como el Levorag®
 - Uso de cremas que disminuyen la hipertonía del esfínter (Rectogesic®). Se puede utilizar durante 2 meses. Efecto adverso: cefalea; si se presenta se debe suspender el tratamiento y acudir a consulta de cirugía general.
 - Toxina botulínica: Alivia la hipertonía del esfínter.

El tratamiento definitivo es quirúrgico, que consiste en una esfinterotomía lateral interna.

ABSCESOS ANORRECTALES

Introducción

Los abscesos anorrectales son colecciones de material purulento en espacios adyacentes al ano y/o recto. El 90% son de origen criptoglandular, aunque también puede ser secundario a una

fístula anorrectal.

La mayoría de los abscesos se originan en la línea pectínea



Clasificación

- Interesfinterianos: situados entre el músculo liso del esfínter interno y el músculo estriado del esfínter externo.
- Submucosos: drenan hacia el canal anal.
- Perianales.
- Isquiorrectales.
- Supraelevadores.

Diagnóstico

- Clínica:
 - Dolor de inicio difuso, perianal, asociado a malestar general y fiebre.
 - Molestias con la defecación.
 - Tumefacción en la región del periano.
 - Calor local.
 - Enrojecimiento.
 - Gangrena de Fournier: es la complicación más grave de un absceso.
- Exploración física:
 - Según su localización puede variar presentándose más frecuentemente como una tumoración dolorosa y ocasionalmente fluctuante en zona perianal.
 - Los abscesos submucosos e interesfinterianos no presentan signos inflamatorios externos. Cursan con dolor anal y al tacto rectal se evidencia tumoración lisa en la parte superior del canal anal y recto inferior, muy dolorosa.
 - Los abscesos supraelevadores suelen ser de difícil diagnóstico ya que se presentan con una sintomatología más insidiosa, sin objetivarse alteraciones perianales, en un paciente séptico con discomfort en zona anal / pélvica. Precisa de una prueba de imagen para su diagnóstico.

- La gangrena de Fournier es una complicación quirúrgica urgente.

Tratamiento

Drenaje y desbridamiento quirúrgico bajo anestesia general o regional. Se deben asociar

antibióticos sólo en inmunodeprimidos, diabéticos, cardiópatas con prótesis valvulares y pacientes sépticos.

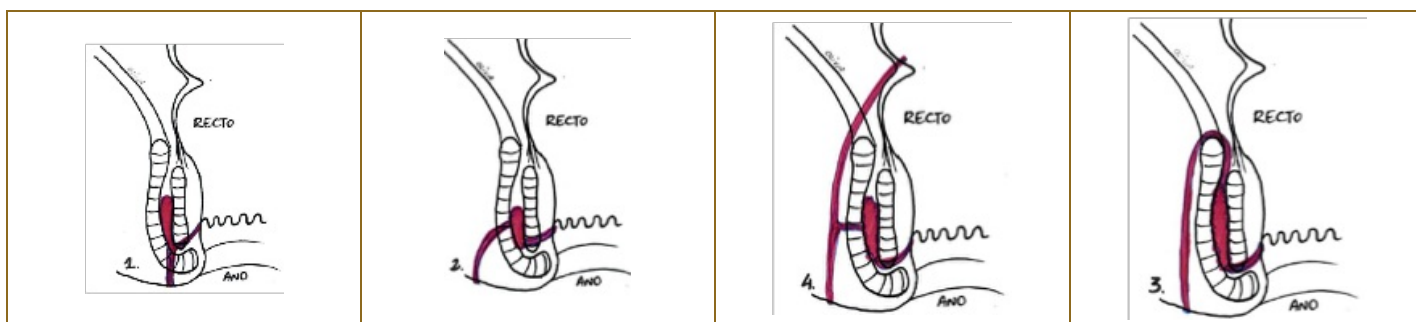
FÍSTULA ANAL

Introducción

La fístula es una conexión entre dos superficies epitelizadas como el canal anal y la piel, que puede atravesar por completo o parcialmente las estructuras musculares perianales. La fístula es la manifestación crónica de un absceso.

Clasificación

- Interesfintérica.
- Transesfintérica.
- Supraesfintérica.
- Extraesfintérica.
- En herradura.



Diagnóstico

- Clínica: secreción de pus, líquido serohemático o fecaloideo por el orificio externo.
- Exploración física: Identificación del orificio externo en la inspección. En el tacto rectal se puede palpar el trayecto fistuloso u orificio interno.

Tratamiento

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.
- Laxantes formadores de bolo (Plantaben): Pueden asociarse en presencia de estreñimiento.
- Analgesia pautada.
- Remitir a Consulta Externa de Cirugía General.
- Si se encuentra en la fase aguda de absceso precisa drenaje y desbridamiento.

SINUS PILONIDAL

Introducción

Formación quística en área sacrococcígea a nivel medial con tejido de granulación, fibrosis e inclusiones pilosas, pudiendo evolucionar a una sobreinfección con la posterior formación de un absceso.

Diagnóstico

- Clínica: presenta los síntomas habituales de un absceso: calor, dolor, tumefacción y rubor.
- Exploración física: absceso sacrococcígeo doloroso y fluctuante.

Tratamiento

En la fase aguda de abscesificación: drenaje y desbridamiento bajo anestesia local.

Derivar al paciente a consulta externa de Cirugía General para exéresis en bloque del sinus una vez haya pasado la fase de absceso.

PATOLOGIA	CLINICA	EXPLORACION	TACTO RECTAL	TRATAMIENTO
Hemorroides	Dolor, prolapso, hemorragia.	Congestivas y edematizadas.	Doloroso.	Analgesia, Daflon®.
Trombosis hemorroidal	Dolor intenso.	Uno o varios nódulos violáceo-negruzco.	Nódulos duros y dolorosos.	Trombectomía.
Fisura anal	Dolor intenso durante la defecación asociado a rectorragia.	Úlcera en línea media posterior del ano.	No realizar.	Analgesia. Rectogesic. Quirúrgico.
Absceso anorrectal	Dolor zona anal, fiebre.	Tumoración perianal dolorosa, fluctuante.	Normal o tumoración dolorosa en canal anal.	Desbridamiento y drenaje quirúrgicos.
Fístula anal	Supuraciones esporádicas. Prurito.	Secreción purulenta por orificio externo.	No doloroso. En ocasiones se palpa el orificio interno.	Quirúrgico. Derivar a cirugía general.
Sinus pilonidal	Dolor y tumoración sacrococcígea. Fiebre.	Absceso fluctuante en línea media sobre sacro y cóccix.	No doloroso.	Drenaje.

BIBLIOGRAFIA

- Abcarian H. Anorectal infection: abscess-fistula. Clin Colon Rectal Surg 2011; 24:14.
- Anal abscess/fistula. American Society of Colon & Rectal Surgeons. 2008. www.fascrs.org/patients/conditions/anal_abscess_fistula/ (Accessed on April 25, 2011).
- Jacobs D. Clinical practice. Hemorrhoids. N Engl J Med 2014; 371:944.

OCCLUSIÓN INTESTINAL

I. Oliva López, LM. Alcoba García

INTRODUCCIÓN

La oclusión u obstrucción intestinal se produce cuando se interrumpe el flujo normal de contenido intraluminal, es decir, existe una ausencia de tránsito intestinal para gases y heces de forma persistente en el tiempo. Puede afectar al intestino delgado o al colon produciendo una dilatación proximal. En el caso de no ser completa ni persistente se utilizaría el término de **Suboclusión intestinal**.

Según su localización puede ser:

- Oclusión de intestino delgado.
- Oclusión de colon.

PATOGENIA

- Íleo paralítico (funcional): alteración de la motilidad intestinal sin causa obstructiva.
- Íleo mecánico (oclusión mecánica): se produce por la existencia de un obstáculo, intrínseco o extrínseco, que impide el tránsito intestinal. Puede ser aguda o crónica.

La oclusión mecánica se define como estrangulada cuando existe compromiso vascular del segmento intestinal afecto pudiendo provocar necrosis o perforación.

El término **pseudoobstrucción intestinal idiopática o Síndrome de Ogilvie** se refiere a una enfermedad producida por alteraciones en los plexos intramurales o en el músculo liso intestinal, con cuadros recurrentes de obstrucción intestinal sin causa mecánica objetivable. En muchos casos precisa endoscopia diagnóstica y descompresiva.

ETIOLOGÍA

- En pacientes con antecedentes de cirugía abdominal la causa más frecuente son las adherencias y bridas postoperatorias.
- En pacientes no intervenidos previamente la causa más frecuente son las hernias de la pared abdominal e inguinales. En frecuencia le siguen las neoplasias colorrectales.

ÍLEO PARALÍTICO	Neurógeno Alteración electrolítica Alteración vascular Infecciones	Postoperatorio de cirugía abdominal, distensión ureteral, pancreatitis, peritonitis, lesión medular. Hipopotasemia. Isquemia intestinal. Neumonías, septicemias.
ÍLEO MECÁNICO	Obstrucción de la luz intestinal: cuerpos extraños, bezoares, fecaloma. Lesiones intrínsecas: Diverticulitis, enfermedad de Crohn, neoplasias, lesiones congénitas estenosantes. Masas extraintestinales: abscesos, quistes, tumores. Bridas o adherencias (congénitas, inflamatorias, neoplásicas, postquirúrgicas). Hernias y vólvulos.	

Etiología de la obstrucción intestinal.

ÍLEO PARALÍTICO

Diagnóstico

Clínica

- Presencia de dolor abdominal no cólico de intensidad leve. En ocasiones hay ausencia de dolor.
- Distensión abdominal.
- Estreñimiento. Pueden aparecer vómitos.
- Clínica del proceso que causa el íleo, aunque suele ser larvada y no destaca por encima de la clínica digestiva (neumonía basal, pancreatitis, cólico renal...)

Exploración Física:

- Distensión abdominal y timpanismo.
- Palpación: dolor abdominal difuso sin signos de peritonismo.
- Tacto rectal normal.

Pruebas Complementarias

- Laboratorio: hemograma y bioquímica con función renal e iones.
- Radiografía de tórax (posteroanterior y lateral): Descartar la presencia de una neumonía basal.
- Radiografía de Abdomen simple: donde se objetivará una dilatación de intestino delgado y de todo el marco cólico con gas en ampolla rectal.

Tratamiento

- Dieta absoluta, canalización de vía periférica y reposición hidroelectrolítica con suero salino fisiológico o glucosalino (2500-3000 ml/día), sonda nasogástrica y enemas de limpieza para estimular el tránsito intestinal.
- El propio de la causa subyacente.

ÍLEO MECÁNICO

Diagnóstico

Clínica

- Dolor abdominal tipo cólico. Se vuelve continuo cuando existe compromiso vascular.
- Distensión abdominal.
- Vómitos biliosos si la obstrucción es alta (intestino delgado) o fecaloideos si es baja (obstrucción de colon).
- Ausencia de tránsito para heces y gases. No es un signo constante, en ocasiones existen deposiciones líquidas (diarrea por rebosamiento) o evacuación de heces distales.

- Diferenciar si la válvula ileocecal es competente en la obstrucción de colon. Si es incompetente observaremos dilatación de colon y de intestino delgado con clínica de distensión y vómitos, precisando de colocación de sonda nasogástrica. Si es competente no existirá dilatación de intestino delgado existiendo mayor riesgo de perforación diastásica e isquémica de ciego.

Exploración Física:

Se debe inspeccionar el abdomen en busca de cicatrices quirúrgicas o hernias.

- Alteración electrolítica y mal estado general por presencia de tercer espacio y vómitos.
- Distensión abdominal y timpanismo.
- Valorar palpando los posibles orificios herniarios: umbilical, epigástrico, Spiegel, inguinal, crural, y descartar masas abdominales.
- Dolor difuso con irritación peritoneal si existe compromiso vascular o complicación de la obstrucción.
- En el tacto rectal podemos objetivar fecaloma o tumor rectal en la oclusión baja de colon.

- En pacientes aóneas con clínica de estreñimiento y oclusión de intestino delgado pensar en la hernia crural que, por su alto riesgo de compromiso vascular, no se debe intentar reducir y es indicación de intervención quirúrgica urgente.

Pruebas Complementarias

- Laboratorio: hemograma (hemoconcentración por pérdida de líquidos, anemia por pérdidas sanguíneas en neoplasias de colon, leucocitosis por peritonitis) y bioquímica con función renal e iones (hipopotasemia, insuficiencia renal por deshidratación).
- Radiografía de tórax (posteroanterior y lateral): Descartar la presencia de una neumonía basal y posible neumoperitoneo (indica la existencia de perforación de víscera hueca).
- Radiografía de abdomen simple: En la oclusión de intestino delgado objetivaremos la dilatación de las válvulas conniventes, imagen típica en “pilas de monedas”, con niveles hidroaéreos en la radiografía
- en bipedestación. En la oclusión de colon con válvula incompetente se observan las haustras del colon y las “pilas de monedas” del delgado; mientras que si es competente sólo se observa dilatación de colon.
- Si la causa obstructiva es un vólvulo de colon se observa la típica imagen en “grano de café”.
 - Aerobilia: Descartar la posibilidad de un íleo biliar.
 - La ecografía no es una buena prueba de imagen en pacientes con oclusión intestinal ya que el aire intraluminal no permite una correcta evaluación.
 - TC abdominal: en la mayoría de los casos se precisa para llegar al diagnóstico final y localización de la obstrucción.



Tratamiento

- Dieta absoluta. Canalización de vía periférica y reposición hidroelectrolítica con suero salino fisiológico o glucosalino (2500-3000 ml/día).
- Sonda nasogástrica en el caso de dilatación de intestino delgado.
- Antibioterapia ante la sospecha de obstrucción estrangulada (Cefuroxima 750 mg/8 horas, Piperacilina-tazobactam (Tazocel®) 4/0,5 g/8 horas, Ertapenem (Invanz ®) 1g/24 horas, Metronidazol (Flagyl®) 500 mg/8 horas, asociarlo cuando se sospecha infección por organismos anaerobios).

Tratamiento específico

- Vólvulo de sigma: puede tratarse con sonda rectal o precisar la realización de una colonoscopia.
- Fecaloma: fragmentación y extracción del mismo. Enemas de limpieza.
- Hernias inguinales: si no hay signos de compromiso vascular se puede intentar la reducción y programar una cirugía preferente; si existen datos de posible compromiso vascular o presencia de una hernia crural, está contraindicada la reducción y la actitud debe ser una cirugía urgente.
- Ante una oclusión por neoplasia de colon se puede intentar la colocación de una guía y endoprótesis trastumoral previo a cirugía diferida o bien, cuando no es posible, cirugía derivativa.
- Síndrome adherencial: observación y tratamiento conservador durante 48-72 horas. Si no se resuelve, valorar intervención quirúrgica.
- Sospecha de compromiso vascular: consulta a cirugía general para intervención quirúrgica urgente.

BIBLIOGRAFIA

- Markogiannakis H, Messaris E, Dardamanis D, et al. Acute mechanical bowel obstruction: clinical presentation, etiology, management and outcome. World J Gastroenterol 2007; 13:432.
- Diaz JJ Jr, Bokhari F, Mowery NT, et al. Guidelines for management of small bowel obstruction. J Trauma 2008; 64:1651.
- Catena F, Di Saverio S, Kelly MD, et al. Bologna Guidelines for Diagnosis and Management of Adhesive Small Bowel Obstruction (ASBO): 2010 Evidence-Based Guidelines of the World Society of Emergency Surgery. World J Emerg Surg 2011; 6:5.

FALTA POR HACER

FALTA POR HACER

FALTA POR HACER